Ces indicateurs pourraient aider les plateaux de préparation des PSL à définir leur spécificité interne « durée de filtration longue », à partir de laquelle des contrôles en levée de doute sont engagés auprès des laboratoires Contrôle Qualité de l'EFS. Cette étude est essentielle en tant que référence actualisée, avant la mise en œuvre de la surveillance des DMU à réception dans le cadre des nouvelles Bonnes Pratiques Transfusionnelles à l'EFS.

Déclaration de liens d'intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d'intérêts.

https://doi.org/10.1016/j.tracli.2019.06.045

P-039

Apport du management qualité au centre de transfusion sanguine de Rabat

Safia Boulahdid [1,*], Aicha Benhadi [1], Fatima Zohra Fazazi Idrissi [1], Souada Naji [1], Bendaoud Adouani [1], Abderraouf Alami [3], Abderrahim Laouina [1], Khadija Hajjout [1], Mohammed Benajiba [2]

[1] *Centre Régional de Transfusion Sanguine de Rabat, Rabat, Maroc*

[2] *Centre National de Transfusion Sanguine et d'Hématologie, Rabat, Maroc*

[3] *Institution Supérieure des Professions Infirmières et Techniques de Santé, Rabat, Maroc*

[*] *Auteur correspondant.*

Adresse e-mail : boulahdid02@yahoo.fr (S. Boulahdid)

Cette étude, a pour objectif d'exposer l'apport du Management de la Qualité (MQ) dans l'amélioration de la sécurité transfusionnelle (ST) et dans la disponibilité des Produits Sanguins Labiles (PSL) et des médicaments dérivés du sang (MDS). Le laboratoire de préparation des PSL, au Centre Régional de Transfusion Sanguine (CRTS) de Rabat, traite plus de 60 000 poches de sang total par an. La complexité de ce processus a nécessité la mise en place d'un système de MQ afin d'assurer la ST et de répondre aux exigences des bonnes pratiques de transfusion marocaines. Par ailleurs, les outils de MQ tel que les audits, les indicateurs et le contrôle de qualité (CQ) ont contribué à la maîtrise de ce processus. Dix-sept audits menés entre 2000 et 2015 ont abouti à une amélioration continue de la qualité des PSL. Le suivi d'indicateurs de performance de la production ont permis de vérifier la fiabilité de ce processus. L'analyse des résultats du CQ, réalisés entre 2010 et 2014, a montré un taux de conformité de 95 % pour les concentrés de globules rouges, de 100 % pour le plasma frais congelé et de 90 % pour les concentrés standards de plaquettes. La démarche qualité à l'échelle nationale, a abouti à la production de PFC répondant aux exigences Bonnes Pratiques Transfusionnelles françaises et Européennes. Ainsi, en 1999, le CNTSH a conclu un contrat de Travail à Façon avec le LFB Biomédicaments pour la fabrication de MDS à partir du plasma marocain. La démarche qualité au CRTS de Rabat a permis la maîtrise de l'ensemble des processus. Le fractionnement plasmatique a contribué à l'amélioration de la ST par l'application et la maîtrise de l'assurance qualité, en plus de l'approvisionnent en MDS.

Déclaration de liens d'intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d'intérêts.

https://doi.org/10.1016/j.tracli.2019.06.046

P-040

Étude de la prévalence du virus de l'immunodéficience humaine (HIV) et du virus de l'hépatite C (HCV) à la Région de Rabat en 2014

Bendaoud Adouani [1,*], El Mehdi Outmani [2], Abderrahim Laaouina [1], Najoua Bouhlal [1], Akkazi Ghazi [1], Youssef Bakri [2], Nadia Dakka [2], Ahmed Bouyoub [1], Khadija Hajjout [1], Mohamed Benajiba [1]

[1] *Centre National de Transfusion Sanguine, Rabat, Maroc*

[2] *Université Mohamed V- Faculté des sciences de Rabat (Laboratoire de biologie des pathologies humaines), Rabat, Maroc*

[*] *Auteur correspondant.*

Adresse e-mail : bendaoud273@yahoo.fr (B. Adouani)

Notre objectif est d'étudier la prévalence de l'HIV et HCV sur les dons de sang au CRTS de Rabat entre janvier et décembre 2014. La qualification sérologique était réalisée par technique : ELISA (enzyme linked immuno-sorbent assay). Les donneurs de sang dépistés positifs pour l'HIV et ou l'HCV ont été convoqués à faire un 2e prélèvement (contrôle sérologique ou ELISA2). À cet effet, les échantillons trouvés positifs ont été congelés a -20 °C jusqu'à leur confirmation par le Western-blot (WB) ou l'immnuno-blot (IB).

Sur un total de 60009 échantillons testés, le pourcentage de rejet des poches de sang réactives ou positives au dépistage de l'HIV était de 0,26 % ($n = 158$), celui du VHC était de 0,49 % ($n = 298$). Ces taux ne reflètent pas la réalité et doivent être analysés avec prudence. Ils pourraient être beaucoup plus faibles par rapport aux valeurs enregistrées. En effet, le résultat des contrôles sérologiques (ELISA2), montre que le pourcentage des faux positifs (négatifs) était de 15 % (11/78) et de 36 % (67/186) respectivement pour l'HIV et pour l'HCV (Tableau 1). De même, ce taux de faux positifs s'élève après la confirmation par le WB ou l'IB des positifs confirmés. Il était de 63 % (42/67) et de 53 % (63/119) respectivement pour l'HIV et l'HCV (Tableau 2). Ceci nous a permis de conclure que la séroprévalence des marqueurs étudiés était très faible par rapport aux valeurs enregistrées et le nombre de faux positifs était très élevé. Donc il serait nécessaire d'intervenir pour remédier à cette situation en instaurant, en routine, d'autres tests plus spécifiques et d'éviter le gaspillage d'une ressource rare tout en assurant un stock suffisant pour nos patients.

Tableau 1 Résultat des marqueurs HIV et HCV chez les donneurs de sang convoqués pour un 2e contrôle sérologique.

	HIV	HCV
Nombre de Donneurs de sang convoqués pour 2ème contrôle	78	186
% positifs	(n= 67) 85%	(n=119) 64%
% négatifs (faux positifs)	(n=11) **15%**	(n=67) **36%**

Tableau 2 Résultat des tests de confirmation chez les donneurs de sang positifs en ELISA2 (2e contrôle sérologique).

	HIV	HCV
Nombre de Donneurs de sang convoqués pour 2ème contrôle	78	186
% positifs	(n= 67) 85%	(n=119) 64%
% négatifs (faux positifs)	(n=11) **15%**	(n=67) **36%**

Déclaration de liens d'intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d'intérêts.

https://doi.org/10.1016/j.tracli.2019.06.047

P-041

Séroconversion, AgHBs, donneurs de sang aux Cliniques Universitaires de Kinshasa

Matondo Manzambi Blaise Sumbu [*], Edunga Julien Bossa, Masidi Jérémie Muwonga, Nkanga Mireille Nganga, Benjamin Longo-Mbenza, Steve Ahuka-Mundeke, Nzongola-Nkasu Donatien Kayembe

Université de Kinshasa/Cliniques Universitaires de Kinshasa/Faculté de Médecine, Kinshasa, République Démocratique du Congo

[*] *Auteur correspondant.*

Adresse e-mail : bsumat@yahoo.fr (M.M.B. Sumbu)

Objectif Le présent travail avait pour objectif d'estimer la séroconversion relative à l'hépatite B chez les donneurs de sang bénévoles et réguliers aux Cliniques Universitaires de Kinshasa au cours de la période allant du 15 mars 2012 au 31 décembre 2014.

Méthode Il s'agit d'une étude de cohorte rétrospective, réalisée chez les DS bénévoles et réguliers qui ont fait au moins deux dons de sang aux Cliniques Universitaires de Kinshasa au cours de la période d'étude.

Résultats Au total, 1051 dons de sang ont été enregistrés provenant d'une cohorte de 352 DS bénévoles et réguliers au cours de la période allant du 15 mars 2012 au 31 décembre 2014. La moyenne d'âge était de $32 \pm 11{,}3$ ans, l'âge médian était de 28 ans, la tranche d'âge la plus représentée était celle de 17 à 25 ans soit 38,5 % (405/1051) et la population estudiantine a représenté 53,9 %

(567/1051) de la population d'étude. Par contre, cette fréquence diminuait avec l'augmentation de l'âge des donneurs de sang. La fréquence de l'AgHBs était de 0,9 % (9/1051) et l'année 2014 a été caractérisée par la fréquence la plus élevée des cas de séroconversion soit 55,6 % (5 cas sur 9 cas positifs). Le taux d'incidence de la séroconversion du virus de l'hépatite B (AgHBs) était estimé à 0,00116 nouveau cas de séroconversion de l'AgHBs par personnes-mois soit 11,6 nouveaux cas de séroconversion de l'AgHBs par 10,000 personnes-mois.
Conclusion La présente étude a montré que le taux d'incidence de la séroconversion de l'AgHBs était faible chez les donneurs de sang bénévoles et réguliers de la Banque de Sang des CUK.

Déclaration de liens d'intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d'intérêts.

https://doi.org/10.1016/j.tracli.2019.06.048

03. Chaîne transfusionnelle, distribution, délivrance et conseil transfusionnel

P-042

La transfusion au Maroc : Mise au point sur la réglementation

Mohamed Ifleh [1,2,*], Khadija Hajjout [1], Khadija Dari [2], Hind Aassila [2], Mohammed Benajiba [1], Abdelkrim Khattabi [2]
[1] *Centre national de transfusion sanguine, Rabat, Maroc*
[2] *Laboratoire agro-alimentaire et santé, université Hassan 1er, faculté des sciences et techniques, route de Casablanca, 77, Settat, Maroc*
[*] *Auteur correspondant.*
Adresse e-mail : iflehmohamed@gmail.com (M. Ifleh)

La transfusion est actuellement encadrée par des règles et des références scientifiques extrêmement rassurantes. Les acteurs intervenant à ces différentes étapes doivent connaître les exigences relatives à sa pratique au risque de voir leur responsabilité engagée, ou celle de l'établissement où ils travaillent, en cas de dommage occasionné au patient du fait de l'absence de leur respect. La loi no 03-94 relative au don, au prélèvement et à l'utilisation du sang et les textes pris pour son application nécessitent une mise au point des exigences législatives et réglementaires qui encadrent la transfusion au Maroc. Elle encourage le don de sang anonyme, volontaire et bénévole et elle prévoit une série de dispositions pour la sélection des candidats au don du sang, la collecte, la qualification biologique du don, la préparation, la conservation, la délivrance du sang et de ses composantes ainsi que pour l'hémovigilance. Cet article fera le point sur la réglementation marocaine relative à l'ensemble du processus transfusionnel de la prescription jusqu'au suivi du receveur en se limitant à l'utilisation des produits sanguins labiles. Il a pour objectif d'identifier les principales exigences réglementaires afin d'adapter le même niveau des connaissances des personnels et de les maîtriser malgré un environnement difficile et dans le respect des droits des patients au regard des bénéfices et des conséquences de l'acte transfusionnel.

Déclaration de liens d'intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d'intérêts.

https://doi.org/10.1016/j.tracli.2019.06.049

P-043

La mise en place d'un nouvel outil de GTA et de planification à l'EFS, une difficile association avec nos activités

Franck Verpoest [*], Nathalie Bleuez, Frédérique Croquet, Thomas Delannay, Amandine Delrue
EFS Région Hauts de France-Normandie Site de Dunkerque, Dunkerque, France
[*] *Auteur correspondant.*
Adresse e-mail : franck.verpoest@efs.sante.fr (F. Verpoest)

Après deux expériences de participation à des projets pour la mise en place d'un nouvel outil de GTA et de planification à l'Établissement Français du Sang (en Région et au National), force est de constater que ce n'est pas chose aisée. La diversité et la singularité de nos activités à l'EFS que sont « la collecte, la production, la qualification biologique du don, et l'IH-Distribution » sans oublier nos activités annexes et connexes, font ressortir une réelle difficulté lorsqu'il s'agit de mettre en place un outil de GTA et de planification unique et harmonisé au sein de celles-ci. L'outil devant intégrer d'un côté les particularités de nos activités, pour une planification simple et efficiente du personnel et de l'autre, des règles légales et conventionnelles en droit du travail qui posent le cadre juridique. À l'arrivée, les parties prenantes y trouvent rarement leur compte, dans un sentiment global que l'outil ne convient pas, n'est pas adapté, et se trouve mal paramétré. Cette difficile association entre contraintes d'activités et règles du droit du travail, ne permettrait-elle pas de réfléchir à une autre voie à l'avenir pour concilier les différents points de vue ? C'est ce que je vous propose de développer.

Déclaration de liens d'intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d'intérêts.

https://doi.org/10.1016/j.tracli.2019.06.050

P-044

Relations entre médecins généralistes et médecine transfusionnelle

J.F. Audouard
Centre hospitalier de Valence, Valence, France
Adresse e-mail : jfaudouard@gmail.com

La médecine transfusionnelle, spécialité médicale complexe couvre un champ de compétences et de connaissances vaste mais reste peu enseignée au cours des études médicales. De ce fait les médecins généralistes ne connaissent pas les étapes de la chaîne transfusionnelle, maîtrisent mal les indications de la transfusion et ignorent les contre-indications au don. Mais nombre de leurs patients donnent leur sang, bénéficient de transfusions et s'interrogent sur les risquent, les conséquences et les règles de la transfusion. Ils se tournent naturellement vers leur médecin pour s'informer. Pour avoir une idée des connaissances que les médecins en activité aujourd'hui ont de la transfusion et définir les relations qu'ils entretiennent avec la médecine transfusionnelle, j'ai envoyé un questionnaire à une centaine de médecins généralistes libéraux en milieu rural ou en ville. Il apparaît que leurs connaissances sont fragmentaires, succinctes, quelquefois très anciennes ou obsolètes. Ils s'orientent peu vers des formations liées à la transfusion pour lesquelles ils ne se sentent par ailleurs pas attirés. Les médecins généralistes et le monde de la transfusion se regardent en chiens de faïence. Mais au vu de ces questionnaires il se dessine néanmoins un timide souhait de coopération, en particulier pour éviter les redondances d'examens, mieux cerner les situations à risque où un don pourrait être délétère. Les médecins traitants ont assurément un rôle important à jouer dans le suivi des donneurs de sang. Ce rôle commence par une meilleure formation en médecine transfusionnelle, des connaissances actualisées et une coopération avec le monde de la transfusion qui reste à réinventer.

Déclaration de liens d'intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d'intérêts.

https://doi.org/10.1016/j.tracli.2019.06.051

P-045

Délivrance des PSL pour les rapatriements sanitaires internationaux : Expérience bordelaise

Mathilde Beguet-Yachine [1,*], Pascal Bouvy [1], Vincent Prin [2], Hamida Chaouky [2], Michel Jeanne [3]
[1] *Service de délivrance des PSL, EFS Nouvelle Aquitaine, Bordeaux, France*
[2] *Société AIRLEC MEDICAL, Mérignac, France*
[3] *Direction EFS Nouvelle Aquitaine, Pessac, France*
[*] *Auteur correspondant.*
Adresse e-mail : mathilde.beguet@efs.sante.fr (M. Beguet-Yachine)

Dans le cadre des rapatriements sanitaires internationaux il existe des besoins transfusionnels potentiels. Chacune des prescriptions de PSL est soumise à autorisation d'exportation par le président de l'EFS par l'intermédiaire de la direction médicale. Il existe depuis juillet 2017 entre l'EFS NVAQ et la société Airlec Médical, basée à Bordeaux, une convention autorisant la reprise des concentrés